Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Trachéotomie : canule bouchée ou retirée

Personne trachéotomisée, adulte ou enfant (MAS, FAM, IEM)

15 IMMÉDIAT · ne respire pas ou respire mal, lutte, cyanose, ne peut plus parler, SpO2 < 90 % (ou sous la cible) ; **canule sortie** ; canule toujours bouchée après aspiration ; saignement par la trachéotomie. **15 et IDE en même temps.**

J'applique si

- Respire mal, canule **bouchée**, **déplacée** ou **sortie**.

Je ne fais pas

- **Réintroduire la canule** (geste IDE ou médecin).
- **Mettre l'oxygène** ou régler le débit (geste IDE).
- Forcer une sonde d'aspiration qui bute ; aspirer sur un orifice non cicatrisé.
- Couvrir l'orifice d'une personne laryngectomisée.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. **Appeler l'IDE** immédiatement ; détresse ou canule sortie : **15 en même temps**.
2. Assise ; matériel de secours du lit à portée (canules, aspiration, BAVU) ; retirer la **valve phonatoire** ou le bouchon.
3. Respire ? Bruits, sifflement, lutte, couleur ; **SpO2** (AS/AP).
4. **Laryngectomie** (respire **seulement** par l'orifice) ? Trachéotomie **récente (< 10 jours)** ? Le dire.
5. Bouchée, orifice cicatrisé : **aspiration endotrachéale** (AS/AP formé) ; canule interne : la retirer si formé, la garder.
6. Canule sortie : **orifice dégagé**, rien posé dessus ; garder la canule pour l'IDE.
7. Ne respire plus : « Arrêt cardio-respiratoire ».

ENSUITE

8. Préparer pour l'IDE : canule de même taille et inférieure, aspiration, O2, BAVU.

J'appelle l'IDE sans délai

- **Tout problème de canule**, même si la personne va mieux.
- Sécrétions plus abondantes, épaisses ou sanglantes ; T° ≥ 38 °C.
- Cordon de fixation lâche, canule qui bouge, alarme du ventilateur.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Respiration, SpO2, couleur, conscience jusqu'à l'arrivée de l'IDE ou du 15.
- Heure, événement, gestes, qui a été prévenu, SpO2.
- À chaque poste : matériel de secours complet ; manque → IDE.

À retenir : Détresse : 15 et IDE en même temps. L'AS/AP formé aspire sur une trachéotomie cicatrisée ; personne d'autre que l'IDE ou le médecin ne recanule ni ne met l'oxygène.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Arrêté du 26/06/2026 (actes), art. 2 B (aspiration endotrachéale AS/AP sur orifice cicatrisé) et art. 4 II (changement de canule) ; HAS, Flash sécurité patient « Trachéo, quand la vie ne tient qu'à un tuyau » (02/2024) ; SPLF, procédures GAVO2 trachéotomie (08/2021) ; protocole DOTR IDE « Trachéotomie : canule bouchée ou retirée (IDE) ».

Réf. DOTR-AS-TRACH | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature